

Rozšírenie Medicaidu a „optimálne začatie“ liečby pri incidenčnom zlyhaní obličiek: výsledky observačnej kohortovej analýzy (2008-2019)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Dostupnosť poistenia sa premieta do toho, či liečba začne pripravené alebo narýchlo.

Prečo sa to rieši

U časti pacientov so zlyhaním obličiek nejde len o to, akú liečbu dostanú, ale aj o to, **ako a v akom čase sa začne**. Prakticky dôležité sú najmä kroky v období pred dialýzou, ktoré môžu zlepšiť priebeh liečby. V tomto kontexte sa v štúdiu hodnotí, či **rozšírenie Medicaidu** (Medicaid expansion) v štátoch USA súvisí s rastom podielu pacientov, ktorí dosiahnu tzv. **„optimal starts“** pri incidenčnom zlyhaní obličiek.

Definícia „optimal start“

Autori definovali **„optimal start“** ako splnenie aspoň jednej z týchto možností, ktoré predpokladajú priaznivejší vstup do liečby:

- **preemptívna transplantácia obličky**, alebo
- **začatie domácej dialýzy** (home dialysis), alebo
- **začatie hemodialýzy v dialyzačnom stredisku s arteriovenóznym prístupom** (in-center hemodialysis s AV prístupom)

Ide teda o kombináciu ukazovateľov kvality predstartovej fázy a pripravenosti pacienta na dlhodobjšiu liečbu.

Dizajn štúdie a populácia

Štúdia bola **observačná** a využila **ročné kohorty** z **US Renal Data System** v období **2008 až 2019**.

- **Populácia:** dospelí vo veku **26 až 64 rokov** s **incidenčným zlyhaním obličiek vyžadujúcim liečbu**

- **Expozícia:** bydlisko v štáte, ktorý **rozšíril Medicaid** alebo nerozšíril od **1. januára 2014**
- **Analytický prístup:** analýza prerušenej časovej série (interrupted time-series) so zameraním na porovnanie zmien trendov **pred a po roku 2014** (teda nie iba jednorazové porovnanie v čase)
- **Veľkosť súborov:**
 - **323 807** pacientov zo štátov s expanziou Medicaid
 - **271 725** pacientov zo štátov bez expanzie
- **Časové okno:** ukončenie sledovania v roku 2019 bolo zvolené tak, aby sa minimalizovali vplyvy pandémie COVID-19
- **Rozšírenie:** týkalo sa **DC a 24 štátov**, zatiaľ čo **17 štátov Medicaid nerozšírilo** a niektoré „intermediate“ štáty boli z analýz vyňaté

Kľúčové výsledky

1) Po roku 2014 sa začal trend rozchádzať

Autori pozorovali, že **pred expanziou Medicaidu** sa „optimal starts“ v štátoch s expanziou aj bez nej vyvíjali **podobným smerom**.

Po roku 2014 však došlo k divergencii:

- rozdiel v **upravenom (adjusted)** podiele „optimal starts“ sa po roku 2014 **zvyšoval**
- do roku 2019 mali štáty s expanziou v upravenej analýze približne **o 3,9 % vyšší podiel** pacientov s „optimal starts“ oproti štátom bez expanzie
- trendová zmena bola štatisticky významná (**P = 0,02**), čo podporuje interpretáciu, že ide skôr o odlišnú zmenu vývoja v čase než o náhodný rozdiel medzi skupinami

2) Najväčší príspevok mala domáca dialýza

Z analýzy vyplýva, že väčšinu rastúceho rozdielu medzi skupinami vysvetľoval najmä sektor:

- **domáca dialýza** (home dialysis), ktorej podiel v štátoch s expanziou po roku 2014 rástol **rýchlejšie** (o **0,29 % ročne** viac než v neexpanzných štátoch)

Naopak:

- **preemptívna transplantácia** zostávala dlhodobo vyššia v štátoch s expanziou, ale nevykazovala porovnateľne výrazný „**post-2014**“ **zlom trendu** ako domáca dialýza
- aj **hemodialýza v centre s AV prístupom** sa relatívne zvyšovala, no bez podobného zlomového efektu po roku 2014

Inými slovami, ak sa rozdiel „zapne“, deje sa to najmä cez **dynamiku domácej dialýzy**.

3) Menila sa poistná dostupnosť a rástla predstartová starostlivosť

Štúdia sledovala aj ukazovatele, ktoré slúžili ako **spostredkujúce proxy pre politiku a prístup**:

- **Medicaid coverage** v expanzných štátoch stúpala o **1,97 % ročne viac**
- **podieľ nepoistených (uninsured)** klesli o **1,04 % ročne viac**

Pokiaľ ide o predstartovú nefrologickú starostlivosť:

- predstartová starostlivosť u nefrológov sa počas štúdie v expanzných štátoch zlepšovala výraznejšie,
- no nezdá sa, že by sa práve po roku 2014 tento trend **ďalej zrýchlil** (skôr ide o dlhšie prebiehajúce zlepšovanie než o bezprostredný „akcelerator“ po zmene politiky)

Dôležité je, že samostatná analýza incidencie neposkytla podporu pre vysvetlenie, že „optimal starts“ by sa zvýšili iba preto, že by narastal celkový počet liečených prípadov.

Interpretácia v klinickom kontexte

Výsledok možno interpretovať tak, že rozšírenie poistného krytia súvisí s tým, ako pacienti vstupujú do liečby pri

incidenčnom zlyhaní obličiek. V štúdii sa to najmä viaže na:

- väčšiu schopnosť využívať **domácu dialýzu v správnom čase**,
- a celkovo priaznivejšie plánovanie alebo pripravenosť na liečbu.

Treba však povedať na rovinu: ide o **observačnú asociáciu**. Štúdia sama uvádza, že neexistuje garancia kauzality, pretože môžu pôsobiť aj ďalšie faktory na úrovni štátov (napríklad iné zdravotnícke programy, organizácia nefrologickej siete, regionálne postupy či rozdiely v poskytovateľoch).

Limity, ktoré znižujú istotu záverov

Pri tomto type analýz je rozumné rátať s týmito limitmi:

- riziko **nezmeraných matúcich faktorov (unmeasured confounding)** na úrovni štátov a zdravotníckych systémov
- nemožnosť úplne vylúčiť vplyv **iných súbežných intervencií** mimo Medicaidu
- štúdia neskúmala klinické výsledky po začatí liečby (napríklad mortalitu alebo komplikácie v nadväznosti na „optimal start“)
- pozorovania sa týkali vekovej skupiny **26 až 64 rokov** a sledovanie bolo ukončené pred pandémiou, aby sa obmedzil jej vplyv

Praktický význam

Pre klinickú prax a organizáciu nefrologickej starostlivosti majú výsledky význam najmä ako signál, že:

- zmena dostupnosti poistného krytia môže súvisieť s tým, či pacienti dostanú šancu na **kvalitnejší vstup** do liečby,
- a že medzi „optimal starts“ sú ukazovatele, ktoré sa menia najvýraznejšie v situáciách, keď sa menia podmienky prístupu, konkrétne cez **domácu dialýzu**.

Ak sa tento trend potvrdí v ďalších štúdiách s presnejšou kauzálnou identifikáciou, mohlo by to posilniť argument, že zdravotné krytie a bariéry prístupu sú súčasťou stratégie „**timely preparation**“ pre dialyzačnú liečbu.

Zdroj: ReachMD – *Medicaid Expansion and Optimal Starts for Incident Kidney Failure*.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=medicaid-a-optimalne-zacatie-pri-incidenčnom-zlyhaní-obličiek> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.